## <2022 본 3 학년말고사- 소아과>

총 **50 문제** 중 **50 문제** 복원

- 21 학년말고사에서 많이 나옴
- 문진화 교수님은 본 1 신경 야마탐
- 올해 한양대가 출제한 임종평 나옴

1. 미숙아는 Gestational age 기준으로 몇주 미만인가?

   - 37 주
   - 36 주
   - 35 주
   - 38 주

2. (19 연말 Y 변형) 상황에 따른 설사 대처 방법으로 옳은 것은?

   - 평소 체중 10kg 이었던 영아가 입원 당시 체중이 9kg 이며, 하루 소변 배설이 없다. 이 환아에게 경구 재수화 용액 (ORS)을 500ml 준다.
   - 하루 10 회 이상 설사하는 아이에게 급속 수액요법 시행한다.
   - 대변 배양검사 결과 salmonella 가 배양된 생후 2 개월 환아에게 (혈액과 소변 배양검사: 음성) 항생제를 주지 않고 경과 관찰한다.
   - 심한 설사한 환아 에게 금식 처방을 한다.
   - 수액 치료를 시행한지 사흘 후 소변량 정상화되고 의식 상태 명료해진 소아에게 WHO ORS 를 마시게 한다.

   1) 중증 탈수이므로 정맥주사로 초기 수액요법 진행
   2) 설사 환아에서 탈수 정도와 하루 수분 필요량을 파악 하여 4 ~ 6 시간 이내에 탈수를 치료해야 한다.
   3) Salmonella 에서 항생제는 균혈증 및 파종 감염의 위험이 높은 3 개월 이하의 영아라면 줘야함.
   4,5) 지속적인 경장 영양이 설사로부터 회복하는데 도움

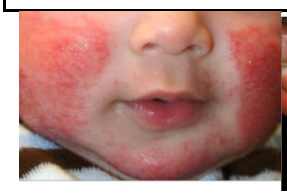
3. (2022 임종평 4 차 한양대) 생후 20 개월 된 남아가 발열을 동반한 호흡곤란과 쌕쌕거림으로 왔다. 생후 6 개월,13 개월 때도 유사한 증상 (호흡곤란, 천명발작)으로 응급실에 갔었던 적이 있으며 가족력에서 어머니가 알레르기비염이 있었다. 체온은 39.5℃ 이며 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 다음 중 급성 세기관지염과 구별하여 영아천식으로 진단할 수 있는 임상 소견 중 맞는 것은?

   WBC 12,000/mm3 , 호산구치 700/mm3,
   혈청 CRP 0.5 mg/dl( 정상치: 0.1~0.8 mg/dl),
   혈청 ESR 11mm/hr (정상치 0~10mm/hr),
   IgE 15 IU/mL (소아 1~5 세 정상치 ~60 IU/mL)

   - 고열
   - 쌕쌕거림
   - 혈청 IgE 15 IU/ml
   - 반복적인 천명발작
   - 총 호산구 700/mm3

4. (2022 임종평 4 차 한양대) 6 개월 된 남아가 8 주 이상 지속되는 심한 가려움증과 홍반, 인설을 동반한 습진성 피부질환을 주소로 왔다. 병변은 아래 사진과 같이 볼과 발목, 발등쪽에 있었으며 심하게 긁어 딱지가 생겨 있었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 다음 중 나쁜 예후인자에 해당되는 환자의 상태는?

   호산구 1000/mm3
   혈청 IgE 45IU/ml (소아 1 세 미만 정상 수치 ~15IU/ml)

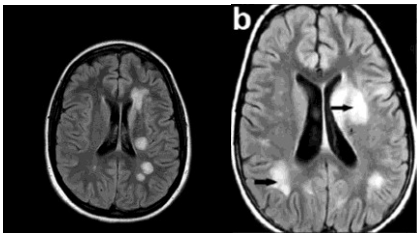
   - 남아
   - 6 개월
   - 혈청 IgE 상승
   - 습진성 피부병변
   - 6 주이상 지속병변

5. (본 1 신경 Y) 5 세 여아 발달이 느린 것과 피부질환, 뇌전증으로 내원하였다. 전신에 1.5-3cm 의 피부반점들이 있었고 어머니에게도 똑같은 병변들이 관찰 되었다. 다음은 피부반점, 무릎 x-ray, MRI 사진이다. 다음과 같은 소견을 보이는 질환에서 나타나는 유전자 이상으로 옳은 것은?




- NF1 유전자 돌연변이
- NF2 유전자 돌연변이
- TSC1 유전자 돌연변이
- TSC2 유전자 돌연변이
- APLD1 유전자 돌연변이

6. (본 1 신경 Y) 5 세 남아가 상기도 감염이 있은지 며칠 뒤 경련, 두통, 구토를 호소했다. 다음은 촬영한 CT 사진이다. BP 110/80, BT 38.1, RR 20, HR 80. 진단명은?




- 급성파종 뇌척수염 (ADEM)
- Sturge-Weber syndrome
- Moyamoya disease
- 부신백색질장애

7. (본 1 신경 Y) 4 세 여아가 40 초 이상 멍하였다. 멍때리는 중에 눈꺼풀이 떨리고 자주 넘어지기도 했다. EEG 상 generalized 2-2.5/sec spike & wave complex 가 나타났다. 진단은?

- Generalized - nonmotor- atypical absence
- Generalized- nonmotor-typical absence
- Focal - awareness (?) - motor- Autonomous
- Focal - Awareness (?) - non motor - cognitive
- Focal - Awareness (?) - non motor - autonomous

8. 모유영양에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 조기 모유 황달 시 모유수유를 중단하지 않는다.
- 초유에는 평소 모유보다 더 많은 지방이 함유되어있다.
- 모유의 지방 함량은 우유보다 많다.
- 모유의 단백질은 주로 casein 이다.
- 완전 모유 수유시 신생아 시기에는 철분을 보충해줘야한다.

*조기 모유황달은 모유수유가 충분치 않아 발생

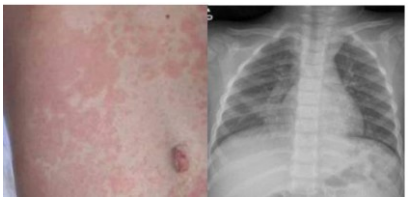
9. 7 세 여아 유방 발달로 내원. 뼈나이 7 세, 유방 태너 2 단계, 음모 태너 1 단계. 진단은?

- 정상 사춘기
- 진성 성 조숙증
- 조기 음모 발생
- 조기 유방 발육
- 사춘기 지연

*성조숙증은 제 2 차 성징의 출현이 여아에서 8 세, 남아에서 9 세 이전에 나타나는 것. 불완전형 성조숙증은 유방비대, 음모, 초경이 단독으로 나타나는 것. 한쪽 또는 양쪽 유방 발육 있으면서 다른 2 차성징을 보이지 않는 일시적인 상태를 유방 조기 발육증이라함

10. 13 세 여아 키 작다고 내원했다. 키 10 백분위, 체중 10 백분위였으며 1 년에 6cm 컸다. 뼈연령은 10 세이고 Tanner stage 2 단계. 아버지 키 175cm, 어머니 키 160cm 이다. 아버지는 키가 고등학교 때 많이 컸다고 하였고 어머니는 초경 16 세였다. 진단은?
    - 체질성 성장지연
    - 터너증후군
    - 쿠싱증후군
    - 가족성 저신장
    - 성장호르몬 결핍증

11. (21 연말 Y) 초등학교에 다니는 9 세 여아가 8 일간 지속된 발열과 발작적인 마른 기침으로 왔다. 두통과 복통도 같이 호소하였다. 체온은 38.4'C, 체간에 사진과 같은 홍반구진상발진(maculopapular eruption)이 있고 양측 폐에서 나음이 청진되었다. 냉응집소 1:128. 해당 질환에 대한 설명으로 옳은 것은?



    - 복통, 심막염, 뇌수막염, 근육통 등 폐외 증상이 동반될 수 있다.
    - 페니실린계로 치료한다.
    - 냉응집소 증가는 이 질환에서만 특징적이다.
    - 일반적으로 매년 유행하고, 여름에 유행한다.
    - 면역력이 약한 영유아가 잘 걸린다.

12. (21 연말 Y) 발열, 기침, 콧물로 내원한 환아. 결막충혈 있었음. 사진과 같은 증상이 있었다. 합병증 중 사망률이 높은 것은 ?

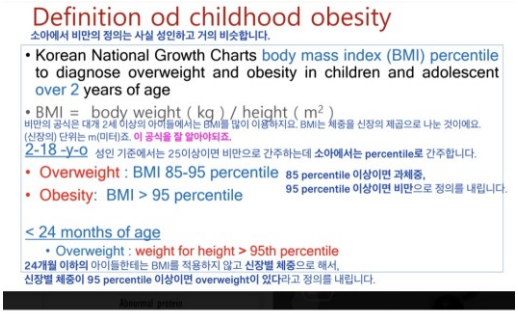


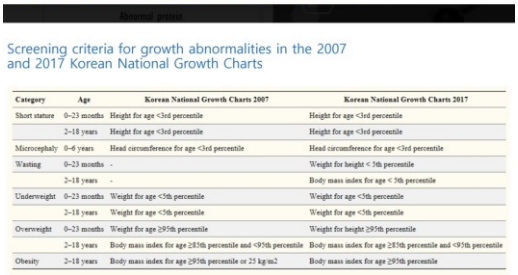
    - 폐렴
    - 중이염
    - 뇌염
    - 관절염

13. 24 개월 미만 유아에서 obesity 정의로 옳은 것은?
    - BMI >95 percentile
    - BMI> 85 percentile
    - Obesity index > 15 Percentile
    - Waist circumference > 95 percentile
    - Weight for height >95 Percentile

최적의 키별 체중과 비교하여 소아 체중의 성장을 평가할 수도 있다. 비만은 키별 체중이 표준치의 120%를 초과하면 확진할 수 있다. BMI가 95백분위수를 넘으면 비만, 85~95백분위수이면 과체중, 70% 미만이면 중증 체중 미달이다.

(홍창의 19p, 24 개월 미만도 해당하는지 모르겠음)



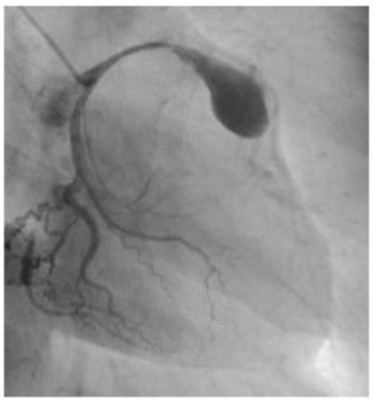

(김용주 교수님 강의록)

14. 30 개월 영아 많이 늦다고 해서 왔다. "엄마" 라는 단어만 말함. 부모랑 눈 잘 마주치지 않고 이름을 불러도 어떤 물건이나 흥미 있는 것을 잘 가리키지 않는다. 혼자서 잘 걷고 뛰고 층계에 오른다. 또래에게 관심이 없다. 한국 영유아 발달 선별 검사 (K-DST)에서 언어, 인지, 사회성, 소근육 영역에서 심화평가 권고를 받았다. 이 환아에서 병력청취 및 신체진찰 후에 해야 할 조치는?
    - 청력검사
    - 발달 정밀 평가
    - 의학적 원인 검사
    - 조기발달중재치료
    - 이상 모두

15. 6 세 남아가 밤에 자는 도중에 소리를 지르고 몸부림을 치며 일어난다. 일어난 후에는 호흡 가쁘고, 동공이 확산되며, 땀에 젖어 있었고, 밤의 상황을 기억하지 못했다. 진단은?
    - 악몽
    - 야경증
    - REM 수면이상
    - 경련

16. 6 살 남자가 의식 저하로 응급실에 내원했다. 검사 결과 혈당 600, Ketone 3+일때 가장 먼저 해야할 치료는?
    - 0.9% Normal saline
    - Insulin
    - 중탄산염
    - 5% dextrose
    - 0.45% NaCl

17. (21 학년말 Y) 44 세 남자가 흉부 방사선 사진에서 이상한 음영이 관찰되어 병원에 왔다. 흉통은 없었고 7 살에 7 일간 지속되는 고열과 목의 임파선 비대로 편도선 수술을 받은 병력이 있다. 심전도는 정상이며 시행한 관상동맥 조영술은 다음과 같다. 원인은?



    - 류마티스열
    - 좌측 관상동맥-폐동맥 이상기시증
    - 관상동정맥 누공
    - 가와사키병
    - 류마티스 관절염

18. (19 연말 Y) 7 살 소아가 중등도의 재생불량성빈혈을 진단받았다. 추가 검사에서 hemoglobin F 가 증가하였고 chromosomal breakage 가 관찰되었다. 올바른 진료 계획은?
    - Prednisone
    - Hematopoietic growth factor
    - Anti-Thymocyte globulin + cyclosporine
    - Hematopoietic stem cell transplantation
    - Transfusion only

*Aplastic anemia 중 HbF 증가, chromosomal breakage 를 보이는 것은 Congenital AA (Fanconi anemia)임. 치료는 HSCT.

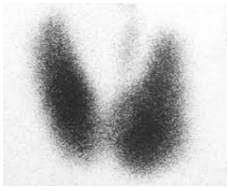
19. 다음이 설명하는 질환을 고르시오.

이 질환은 초기 태아 발생 시에 22 번 염색체의 부분 결손으로 인해서 생기는 복합 질환입니다. 부모로부터 유전되는 경우(congenital)는 약 5% 정도이며, 95%는 돌연변이(sporadic)의 결과입니다. 기형은 나중에 갑상선과 부갑상선으로 발달하는 3 번째, 4 번째 인두낭(pharyngeal pouch)으로 알려진 부분에서 나타납니다.
심장 결함(Cardiac defects), 비정상 얼굴 모양(Abnormal facial features), 흉선 발육 부전(Thymus underdevelopment), 구개열(Cleft palate), 저칼슘혈증(Hypocalcemia)이 디 죠지 증후군의 특징입니다. 각각의 첫 글자를 따서 CATCH 라는 약어로 표현하며, 이 질환이 염색체 22 번 결손에 의해 일어나므로, CATCH-22 로 부르기도 합니다. 얼굴 특징은 넓게 퍼진 눈, 처진 귀, 작은 턱과 좁고, 짧은 인중입니다.

(이런 식으로 DiGeorge syndrome 의 원인, 유전, 임상증상, 검사소견, 치료에 대한 글이 나왔습니다)

- DiGeorge syndrome
- Wiskott-Aldrich syndrome
- Severe combined immunodeficiency
- Chediak-Higashi syndrome

20. 생후 10 일된 남아가 선천대사이상검사(생후 3 일) 에서 발견된 T4 의 감소로 내원함. 다음은 혈액검사 소견과 갑상선스캔 결과이다. 진단은? (주)



free T4 정상 T3,T4 감소 TSH 정상 TRB 항체 : 음성

(수치와 정상범위 같이 나왔습니다)

답 : TBG 결핍

**(1) TBG 결핍**

주로 $T_4$를 측정하는 신생아 선별 검사에서 발견되는데, X 연관(반성) 우성 양식을 취하므로 남아에 많다. 남아 출생 1,700명당 1명꼴로 나타난다. 유전 인자는 X 염색체의 단완에 위치하고, codon mutation이나 점 돌연변이에 의하여 나타난다.

낮은 $T_4$ 농도를 보이나 유리 $T_4$ 농도와 TSH 농도는 정상이며, 낮은 TBG 농도로 확진한다(TBG 결핍 환아의 36%에서는 TBG 농도가 1mg/dL 미만, 완전 결핍 때에는 0.5mg/dL 미만). 이때 $T_3$ resin 섭취는 상승되어 있다. 증상은 없으며 치료할 필요가 없다.

21. 철결핍 빈혈이 의심되어 혈중 철을 투여하였다. 철결핍 빈혈을 진단하기 위해서 올바른 검사항목과 검사시기가 연결된 것은?

- 망상적혈구 - 7 일
- 혈중 페리틴 - 7 일
- 혈중 철 - 1 개월
- 혈색소 - 3 개월

22. 3 세 남아 경련을 주소로 내원하였다. 발열이나 의식저하는 없었으며 5 분간 전신을 떠는 양상의 경련이었다. 다음은 혈액검사 소견결과이다. 진단은? (주)

Ca 5.8, P 10.6, ALP 550
PTH 감소
25(OH)vit D 정상

(PTH 와 vit D 수치와 정상범위 나와있었습니다.)

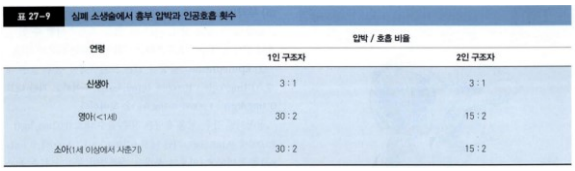
답 : hypoparathyroidism

23. 아나필락시스에 대한 설명으로 옳은 것?

- 호흡곤란 증상만으로 진단 가능하다.
- 피부,점막 소견만으로 진단 가능하다.
- 증상에 대한 초기 응급처치로 H2 blocker 근육주사한다.
- 증상에 대한 초기 응급처치로 에피네프린 근육주사한다,
- 소아에게 흔한 원인은 꽃가루 알레르기이다.

24. 7 세 남자 아이 키 작다고 내원했다. 키 117cm (1 백분위수), 몸무게 20.4kg (10 백분위수)였다. 1 년에 4cm 씩 컸다. 뼈연령은 5 세였다. 아버지 185cm, 어머니 162cm 이고 갑상선호르몬 기능검사 정상이었다. 다음 해야 할 검사는?
    - 금식 후 성장호르몬 농도 측정
    - 수면 중 성장호르몬 농도 측정
    - 인슐린 투여 후 성장호르몬 농도 측정
    - 금식 후 IGF-1 농도 측정
    - 운동 후 IGF-1 농도 측정

25. 5 세 남아가 갑자기 심정지가 왔다. 1 인 구조자 흉부압박과 인공 호흡 비율 몇 대 몇인가?
    - 30:2
    - 30:1
    - 15:2
    - 20:2
    - 10:2



| 표 27-9 심폐 소생술에서 흉부 압박과 인공호흡 횟수 | | |
|---|---|---|
| 연령 | 압박 / 호흡 비율 | |
| | 1인 구조자 | 2인 구조자 |
| 신생아 | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 영아(<1세) | 30 : 2 | 15 : 2 |
| 소아(1세 이상에서 사춘기) | 30 : 2 | 15 : 2 |

26. 아세트아미노펜 중독시 사용해야 할 것은 무엇인가?
    - N-Acetylcysteine (NAC)
    - Pyridoxine
    - Deferoxamine
    - Ethanol solution IV
    - Methylene blue

27. RDS 사진주고 치료는? (21 학년말 26 번 유사)

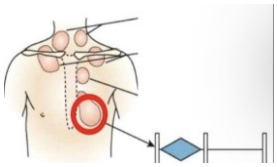


    - Surfactant PO
    - Surfactant IV
    - Surfactant 기관내
    - PO dexamethasone
    - IV dexamethasone

28. 영유아 호흡기 특징으로 옳은 것?
    - 상기도 안지름은 크고 후두개는 작다.
    - 성인에 비해 점액샘 밀도가 낮아 분비가 적다
    - 연골이 잘 발달되어있어 협착이 잘 안된다.
    - 늑간근의 제 2 연축섬유 많아 지속적 호흡에 유리하다.
    - 2 세에 성인 호흡으로 전환된다.

*성장하면서 후두개, 설골, 후두 연골의 하방 이동, 혀의 후방 이동. 얼굴 골격의 상하 성장과 턱의 전후방 성장 등의 상기도 발달이 진행되어 2 세경에는 성인형 호흡 운동으로 전환된다.
*늑간 호흡근이 대부분 피로에 잘 견디지 못하는 제 2 형 속성 연축 섬유로 구성되어 있어 호흡 운동의 지속성에 불리함. 기도에는 점액샘의 밀도가 높아 염증이 생겼을 때 쉽게 많은 점액이 분비

29. (2022 4 차 임종평 한양대) 5 세 남아가 예방접종을 위해 병원에 방문하였다가 심잡음이 발견되었다. 최근 감기 걸린 적 없었으며, 지금까지 특별히 크게 아팠던 적은 없었다. 성장 및 발달 상태는 양호하고, 잘 먹고 체중도 잘 늘고 있었다. 진찰상 좌측 흉골 하방에서 수축기에 심잡음이 들렸으며, 누워 있을 때 더 잘 들리는 양상이었다. 체온 36.8 도, 맥박 80 회/분, 호흡수 24 회/분이었고 건강해 보이는 모습이었다. 진단은?



    - 정맥성 잡음
    - 경동맥 잡음
    - 스틸 심잡음
    - 동맥관 개존증
    - 심방중격결손

30. (2022 4 차 임종평 한양대) 13 세 여아가 매년 환절기때마다 생기는 코가려움, 코막 힘, 재채기, 콧물, 훌쩍거림, 눈가려움 증상을 주소로 왔다. 어려서 아토피 피부염을 앓았으며 어머니가 어렸을 때 천식을 앓았었다고 한다. 혈액 검사는 다음과 같았다. 내원시 콧물 재채기로 학교생활에 불편함이 있어 2 주간 치료 후 다시 병원에 오기로 하고 약을 처방하였다. 2 주간 처방할 수 있는 치료제로 옳은 것은?

| 호산구 1000/mm3, 혈청 IgE 570 IU/mL |
|---|

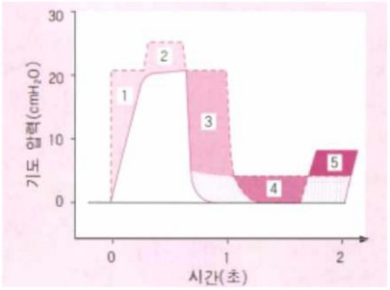
- 비충혈 제거제 (Decongestant)
- 스테로이드 국소 분무제 (nasal spray)
- 항생제
- 전신 스테로이드제
- 흡입 스테로이드제

31. (연말 Y) 5 세 소아가 경련해서 내원. 짧은 경련을 보였으며 심전도 상 QT prolongation 을 보였다. Glucose 75mg/dl, Na 138mEq/L, P 8, iCa 2.1 일때 치료는?
- Calcium gluconate
- 마그네슘
- 활성 비타민 D 투여
- Bicarbonate

32. 39 주 2400g 키 49cm, 머리둘레 34cm 으로 비대칭적으로 성장. 원인으로 흔하지 않은 것은?
- 선천성 풍진
- 산모의 만성적인 고혈압
- 산모의 만성적인 합병증을 동반한 당뇨
- 산모의 임신 말기 영양결핍
- 임신 중 전자간증 Calcium

33. 8 개월 남아가 3 일전부터 발열, 콧물, 기침 있었고, 1 일전부터 전부터 기침이 심해지면서 먹지 못하고 쳐졌다고 한다. 양쪽 가슴에 갈비사이 뒤당김이 있다. 가슴청진에서 날숨에서 쌕쌕거렸고, 심잡음은 없다. 치료는? WBC 14900, 호산구 700 였음.
- 에피네프린 흡입
- 수액보충
- 항생제 치료
- 스테로이드 정주
- 진정제 투여

34. 평균 기도압력을 높이는 방법으로 3 에 해당하는 방법은?




- 흡기 유속 증가
- 최대 흡기 압력 증가
- 호흡 횟수 변경 없이 흡기 시간을 연장시킨다.
- 호기말 양압을 증가시킨다.
- 호기 시간을 줄여서 인공환기의 환기수를 증가시킨다.

35. (20 연말 Y) 정상 신생아의 혈액순환으로 옳은 것은?
- 출생 후 전신 혈관 저항이 급격하게 증가한다.
- 출생 후 폐동맥 저항이 급격하게 증가한다
- 동맥관은 생후 8 살에 자연스럽게 닫힌다
- 우심실 박출량이 좌심실 박출량의 1.3 배이다
- 우심방으로 들어온 정맥혈은 대부분 동맥관으로 흐른다.

36. 40 주 3.9kg 목에 탯줄 감겨 숨 제대로 쉬지 않음. 1 분 Apgar 2 점, 5 분 Apgar 4 점으로, pH 6.98, CO2 49.8, O2 63, HCO3 11.8, BE -20 치료는? Asphyxia, 생후 1 시간 (아기 사진 주어짐)
- 저체온요법
- 항생제
- 스테로이드

37. (19 연말 Y 변형) 소아 만성 기능성 복통 증후군에 대해 옳은 것은?
- 주로 상복부 통증을 호소한다.
- 6 세 이전에 흔하다.
- 주로 식사 전에 아프다
- 일상생활 (학교 수업 등) 을 할 수 없을 정도로 아프지는 않다.
- 설사, 변비와 같이 동반되는 경우가 많다..

*Most often periumbilical,, Onset >6yrs.
The pain interrupts normal life activity,
Usually no relation with meals
(김용주 P 강의록)

38. 정상 신생아 소견 아닌 것은 ?
- 구순 결절
- 백색 동공반사
- 움직일 때 턱과 다리가 떨린다
- 할리퀸 색조변화
- 조직검사시 호산구가 보이는 작은 수포성 발진

*선지 구순 결절이 아니라 구순열이라는 말도 있습니다..
*농포내 호산구가 많은 것: 독성 홍반

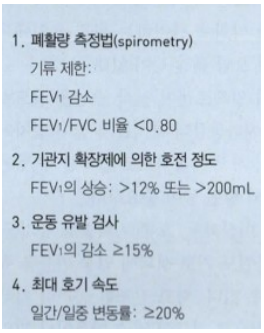
양안에 적색 반사(red reflex)가 있으면 백내장이나 눈 속에 병변이 없음을 암시한다. 백색 동공(leukocoria) 반사가 있으면 백내장, 종양, 맥락망막염(chorioretinitis), 미숙아망막병증 또는 지속 증식 원발 유리체증(persistent hyperplastic primary vitreous)을 의심해야 하며, 안과 검사를 꼭 해야 한다.

39. (연말 Y) 신생아 진찰 정상 소견은?
- 독성홍반 (erythema toxicum)
- 사경 (torticollis)
- 관절굴곡증 (arthrogryposis)
- 두개혈종 (cephalhematoma)

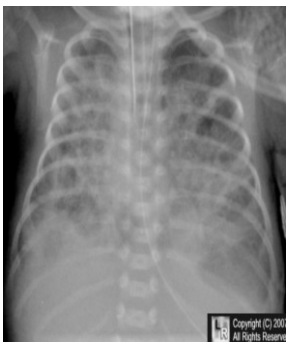
40. (연말 Y) 10 세 남아가 급성 췌장염 소견에 대한 치료로 일주일 넘게 금식하다가 배가 너무 고파하자 보호자가 몰래 간식을 사와 먹였다. 2 시간 후 환아의 양손에 tremor 가 나타났고 아이가 심한 복통, 구토를 호소했다. 다음 중 추적해야 하는 수치는?
- Calcium
- Phosphorus
- Ammonia
- Chloride
- Glucose

41. 14 세 여자가 지하철을 타고 가다가 쓰러졌고, 10 초 뒤에 다시 일어났다. 일어나고 나서는 손떠는 증상은 없었다. 평소에 자주 어지러웠다고 한다. 두통이나 구토도 없었다. 누웠을 때 혈압 110/70, 섰을 때 혈압 100/80, 심박수 16(?)이었다. 진단은?
    - Vasovagal syncope (미주신경성 실신)
    - Postural hypotension (체위성 저혈압)
    - Cardiomyopathy (심근병증)
    - Ventricular tachycardia (심실빈맥)

42. 소아 기관지천식은 살부타몰 투여 10-15 분 후 FEV1 이 ( )%이상 증가했을 때 진단 가능하다.
    - 12%
    - 7%
    - 20%
    - 15%
    - 9%

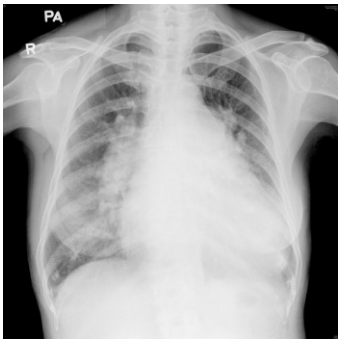

1. 폐활량 측정법(spirometry)
기류 제한:
$FEV_1$ 감소
$FEV_1$/FVC 비율 <0.80
2. 기관지 확장제에 의한 호전 정도
$FEV_1$의 상승: >12% 또는 >200mL
3. 운동 유발 검사
$FEV_1$의 감소 ≥15%
4. 최대 호기 속도
일간/일중 변동률: ≥20%

43. (18Y) 28 주, 1800g 으로 태어난 아기 RDS 있어 인공환기 시행함. PDA 발생하여 인도메타신 치료하였고, 생후 1 개월에는 장문제로 수술함. 생후 2 개월 될 때까지 인공환기 시행하였고 인공환기 제거하면 청색증 발생한다. 진단은?



    - TTN
    - 기관지폐이형성증
    - 유리질막증
    - 폐렴

44. (21Y 학년말) 4 세 시설에 있는 소아가 숨이 차고 입술이 파래져서 병원에 왔다. 신생아 때 심장병이 있다고 들었으나 치료받지 않았다. 현재는 청색증이 없지만 땀이 많이 났다. 좌흉골연 4 연에서 3/6 의 심잡음, 2 연에서 P2 항진, 심첨부에서 4/6 의 확장기 심잡음이 들린다. 진단은?




    - Eisenmenger syndrome
    - ASD
    - PDA
    - Valvular pulmonary stenosis
    - TOF

45. (2022 4 차 임종평 한양대) 4 개월 여아가 얼굴이 파랗게 보여 병원에 왔다. 심하게 울다가 청색증이 더 심해졌다. 출생 직후부터 심잡음이 들린다는 얘기를 들었으나 심초음파를 시행한 적은 없었다. 체온은 37.8 도, 혈압은 60/45mmHg, 맥박 130 회/분, 산소포화도는 40%였다. 진찰상 현재 심잡음이 들리지 않았다. 가슴 X 선 사진이다. 치료는?



- 모르핀 근주
- 디곡신
- 항생제 투여
- 이뇨제 정주
- 전기적 심율동전환

46. 16 개월 남아가 7 시간 전부터 발생한 기침으로 병원에 왔다. 가슴 청진에서 쌕쌕거림이 들렸고 심잡음은 없다. Chest X-ray 소견 주어짐. 세균 감염의 증거는 없었다. 치료는?

(사진 실제와 다름. 구글에서 RSV infection 사진 가져온 것)



- 항생제 치료
- 진정제 투여
- 팔리비주맙 투여
- 산소치료
- 목 굽힌 자세 유지

47. 심박수 50, 호흡 느리고 불규칙, 사지는 약간 굴곡되어 있었고 피부는 청색이었다. 카테터 자극에 반응 없었다. 5 분 APGAR score 는?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

48. 신생아의 5 분 신체 검진 결과이다. 심박수 50, 호흡 느리고 불규칙, 사지는 축 늘어져있었고 피부는 전신이 청색, 카테터를 코에 넣었을 때 반응 없었다. 5 분 APGAR score 는?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

49. 임신 27 주에 ROM, labor 있어 산모가 제왕절개를 했다. 생후 1 분에 심박수 50, 호흡 없고, 온몸이 창백했으며, 사지 늘어져 있고 카테터 자극에 반응 없었다. PPV 후 생후 5 분 심박수 110, 호흡 느리고 불규칙해졌다. 1 분 apgar score 는?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**표 11-9 Apgar 채점 기준**

| 증상 \ 점수 | 0 | 1* | 2 |
|---|---|---|---|
| 심박수 | 없다 | <100 | ≥100 |
| 호흡 | 없다 | 느리거나 불규칙하다 | 양호, 잘 운다 |
| 근력 (muscle tone) | 늘어져 있다 | 사지를 약간 굴곡 | 활발히 움직인다 |
| 코에 카테터를 넣었을 때의 반응** | 반응 없다 | 얼굴을 찡그린다 | 기침을 하거나 재채기를 한다 |
| 피부의 색깔 | 청색 또는 창백 | 동체는 홍색, 손발은 청색 | 전신이 분홍색 (pink) |

* 신생아가 출산된 후 1분에 채점한 점수가 10점 만점에 0~3점이면 즉각적으로 소생술을 시행해야 한다.
** 입안두의 이물질을 제거하고 시행한다.

50. (출생과 성장 Y) 임신 나이 40 주, 출생체중 3.5kg 로 태어난 생후 3 일 신생아가 열이 나서 병원에 왔다. 소변량이 줄더니 안 나왔고 피부가 얼룩덜룩했다. 산모가 임신 중 열이 났지만 병원에 가지 않았다. 이와 관련된 신생아 감염의 특징으로 옳은 것은?

- TORCH 감염은 대부분 ascending infection 이다.
- 산모의 열, ROM, 재태주수 등이 중요하다.
- WBC 의 감소보다는 증가가 더 의미있는 소견이다.
- Urine culture 는 진단에 유용하다.
- 경험적 항생제로는 주로 ampicillin + 1 세대 cephalosporine 계를 선택한다.

*TORCH 는 태반 전달